HANDOUT · PFLEGEAUSBILDUNG

Gruppe Takiyat & Sami
Nichtraucherberatung
nach S3-Leitlinie

Grundlagen einer Beratung

Was Beratung in der Pflege ausmacht – mit Beispielen aus unserer Nichtraucherberatung (Takiyat & Sami).

> **Beratung** ist ein ergebnisoffenes, dialogisches Gespräch: Die Pflegefachperson unterstützt die Person dabei, ihre Situation zu verstehen, Möglichkeiten abzuwägen und **selbst eine Entscheidung** zu treffen. Die Entscheidung bleibt bei der Patientin oder dem Patienten.

1 Beratung ist nicht dasselbe wie …

Information	Schulung	Anleitung	**Beratung**
gezielte Weitergabe von Wissen, z. B. ein Infoblatt oder eine kurze Auskunft.	geplante, strukturierte Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, oft mit festem Ablauf.	praktische Fertigkeiten zeigen und gemeinsam üben, z. B. ein Pflaster richtig aufkleben.	Dialog auf Augenhöhe, ergebnisoffen; die Person findet ihre eigene Lösung.

In der Praxis greifen die Formen ineinander: In unserem Gespräch informiert Takiyat (Infoblatt), berät aber vor allem – Sami entscheidet selbst.

2 Die Haltung: personenzentriert (nach Carl Rogers)

Empathie
sich in die Situation der Person einfühlen und das Verstandene zurückmelden.

Akzeptanz
die Person wertschätzen, ohne zu bewerten – auch wenn sie (noch) raucht.

Echtheit
ehrlich und stimmig sein, keine Rolle spielen (Kongruenz).

„Danke, dass Sie mich nicht belehrt haben." – Sami. Gute Beratung belehrt nicht, sie begleitet.

3 Gesprächstechniken – mit Beispielen aus dem Dialog

Um Erlaubnis fragen
„Dürfte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das mit Ihrer Lunge zu tun hat?"

Offene Fragen stellen
„Was hat Ihnen beim letzten Mal in den drei Wochen geholfen?"

Würdigen & Selbstwirksamkeit stärken
„Drei Wochen sind eine echte Leistung."

Skalierungsfrage
„Auf einer Skala von null bis zehn: Wie wichtig ist Ihnen das Aufhören gerade?"

Eigene Gründe hervorlocken
„Eine Acht. Und warum keine Fünf?"

Zusammenfassen & vereinbaren
„Dann halten wir fest: …"

Außerdem: aktives Zuhören (Blickkontakt, Nicken, Pausen aushalten), Paraphrasieren (mit eigenen Worten wiedergeben), Gefühle ansprechen („Und trotzdem ist es schwer, oder?"), Ich-Botschaften, verständliche Sprache ohne Fachjargon.

4 Ablauf eines Beratungsgesprächs

1 Vorbereitung	2 Einstieg	3 Situation klären	4 Lösungen	5 Vereinbarung	6 Abschluss
Ziel, Zeit, ruhiger Ort, Infos zur Person	Begrüßung, Befinden, Erlaubnis für das Thema	Ist-Zustand, Erfahrungen, Motivation erfragen	Möglichkeiten gemeinsam erarbeiten, Person entscheidet	konkrete Schritte festhalten, zusammenfassen	Folgekontakt, Dokumentation, Evaluation

PRAXISBEISPIEL

Nichtraucherberatung: die 5 A

Kurzberatung nach der S3-Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit“ (2021) – die 5A-Methode gibt dem Gespräch Struktur.

Ask Abfragen	Rauchstatus erfragen und dokumentieren	*„Wie viel ist es im Moment am Tag?“* – „So zwanzig Stück.“
Advise Anraten	individuell und motivierend zum Rauchstopp raten	*„Bei Asthma löst Rauch Anfälle aus und schwächt die Wirkung Ihrer Medikamente.“*
Assess Ansprechen	Aufhörmotivation erfassen; Abhängigkeit einschätzen (Fagerström-Test)	*„Wann rauchen Sie morgens die erste Zigarette?“* · Skala 0–10: „Eine Acht.“
Assist Assistieren	beim Rauchstopp unterstützen oder an Angebote weiterleiten	Nikotinersatz (Pflaster + Kaugummi) mit der Ärztin besprechen, Telefonberatung, Online-Programm, Infoblatt
Arrange Arrangieren	Folgekontakte vereinbaren	*„Und morgen früh frage ich nach, wie die Nacht war.“*

Kürzere Variante: **ABC-Methode** – Ask, Brief advice, Cessation support. Laut S3-Leitlinie wird keines der beiden Modelle bevorzugt; zentral ist bei beiden die Weiterleitung an qualifizierte Hilfsangebote.

M Motivierende Gesprächsführung

- **Empathie ausdrücken** – Ambivalenz ist normal („Und trotzdem ist es schwer, oder?“).
- **Diskrepanz entwickeln** – zwischen Rauchen und eigenen Zielen („wieder Fußball spielen“).
- **Widerstand nicht bekämpfen** – Einwände ernst nehmen („Ist das nicht auch Nikotin?“).
- **Selbstwirksamkeit stärken** – an Erfolge anknüpfen („Da wissen Sie schon, dass Sie es können.“).

Nach Miller & Rollnick. Die S3-Leitlinie empfiehlt Motivational Interviewing für Rauchende mit geringer Änderungsbereitschaft.

S3 Wichtige Empfehlungen

- **A** Rauchstatus systematisch erfragen und dokumentieren.
- **A** Kurzberatung soll auch in der **pflegerischen** Versorgung angeboten werden.
- **A** Stärke der Abhängigkeit mit dem Fagerström-Test (FTZA) einschätzen.
- **A** Nikotinersatztherapie anbieten; bei unzureichender Wirkung Kombination aus Pflaster + schnell wirksamem Präparat.
- **A** Medikamente immer mit begleitender Beratung kombinieren.
- **A** Qualitätsgesicherte Telefonberatung anbieten.
- **A** Im Krankenhaus: Entwöhnung dort beginnen, unterstützender Kontakt über mindestens einen Monat.

A = starke Empfehlung („soll“).

Rauchfrei-Telefon 0800 8 31 31 31
kostenlos · Beratung des BIÖG, auf Wunsch mit Rückrufen in der Ausstiegsphase

rauchfrei-info.de
kostenloses Online-Ausstiegsprogramm

Quellen: S3-Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung“, AWMF-Register Nr. 076-006, Version 2021 (Langfassung, Kap. 3–4). · Miller, W. R. & Rollnick, S.: Motivierende Gesprächsführung. · Rogers, C. R.: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. · Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG): rauchfrei-info.de, Telefonberatung zur Rauchentwöhnung.